1.4.1. 낙상 예방

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서	간호국				

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 1.4 낙상 예방활동 JCI Standard 7th Edition: IPSG.6, 6.1

제1조 (목적)

1. 의료기관 내 낙상으로 발생되는 환자 상해 위험을 줄이고 예방하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 낙상: 외부의 힘, 의식소실, 갑작스러운 마비에 기인되어 넘어지는 것을 제외하고 갑작스러운 비의도적인 자세변화 때문에 바닥과 기타 물체 등으로 본래 몸의 위치보다 낮아지는 것

제3조 (절차)

1. 입원환자 낙상위험 관리
   1) 평가대상: 모든 입원환자를 대상으로 낙상위험요인을 평가하고 기록한다.
   2) 낙상평가도구
      (1) 성인: Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool(2007) '낙상위험요인평가(성인)' 도구
      (2) 소아청소년(만 18세 이하): GRAF-PIF(General Risk Assessment for Pediatric In-Patient Falls) '낙상위험요인평가(만 18세 이하)' 도구
   3) 낙상위험요인 평가시기
      (1) 초기평가: 입원 24시간 이내
      (2) 재평가: 입원 중 환자상태 변화 시 재평가를 시행하며, 구체적 시기는 다음과 같다.
         ① 병동 이동 시
         ② 수술/침습적 시술 시
         ③ 낙상 주의 약품 복용 시: PCA/마약, 향정신성약물, 항전간제, 항고혈압제, 이뇨제, 진정제, 최면제, 완하제 등 복용 시
         ④ 움직임이나 인지변화 발생 시
         ⑤ 상태변화가 없는 환자의 경우 일주일 간격으로 낙상 위험요인을 재평가한다. 단, 재활병원에 입원한 환자는 2주마다 재평가한다.
   4) 성인 낙상 위험 분류 기준
      (1) 낙상 고위험군
         ① '낙상위험요인평가(성인)' 14점 이상인 경우
         ② 6개월 이내에 2회 이상의 낙상을 경험한 환자
         ③ 현 재원 기간 중 낙상을 경험한 환자

(2) 낙상 중위험군

① '낙상위험요인평가(성인)' 6점 이상 13점 이하인 경우

(3) 낙상 저위험군

① '낙상위험요인평가(성인)' 5점 이하인 경우

② 전신 마비 또는 전혀 움직이지 못하는 경우

5) 소아청소년 낙상 위험 분류 기준

(1) 낙상 고위험군

① '낙상위험요인평가(만 18세 이하)' 2점 이상인 경우

② 12개월 미만

(2) 낙상 저위험군

① '낙상위험요인평가(만 18세 이하)' 2점 미만인 경우

2. 입원환자 낙상 예방

1) 낙상 고·중·저위험군 환자 낙상 예방 활동

(1) 낙상 고위험군

① 낙상 발생 위험 환자임을 팔찌에 표시하여 환자, 보호자 및 직원과 정보를 공유한다.

② '낙상 예방 중재 활동'을 하루 2회 이상 실시하고 기록한다. (간호진단 '낙상의 위험' 또는 '상해의 위험' 적용)

③ 낙상 고위험군임을 담당 간호사 변경 시마다 인계하여 관리한다.

(2) 낙상 중위험군

① 낙상 발생 위험 환자임을 팔찌에 표시하여 환자, 보호자 및 직원과 정보를 공유한다.

② '낙상 예방 중재 활동'을 하루 1회 이상 실시하고 기록한다. (간호진단 '낙상의 위험' 또는 '상해의 위험' 적용)

③ 낙상 중위험군임을 담당 간호사 변경 시마다 인계하여 관리한다.

(3) 낙상 저위험군

① 'Environment management' 프로토콜을 이용하여 기본적인 낙상예방 간호중재를 실시하고 기록한다.

2) 낙상 예방 중재 활동

(1) 공통

① 입원 시 모든 환자를 대상으로 '낙상 예방 지침'을 사용하여 환자 및 보호자에게 교육하고, '낙상주의' 게시물을 침상에 부착한다.

② 보호자가 바뀔 경우 '낙상 예방 지침' 내용을 인계하도록 교육한다.

(2) 병동

① 병실 순회 시 낙상위험요인이 있는지 점검한다. (예: 보호자 유무, 침대난간 위치, 침대바퀴 고정상태 등)

② 낙상 예방법에 대한 교육: 환자 및 보호자에게 낙상 예방법에 대한 교육을 시행한다. (예: 수면 전 화장실 다녀오기, 보호자 동반하여 거동하기, 낙상 예방을 위한 시설물 이용 방법, 미끄럽지 않은 신발 착용 등)

③ 필요 시 의학적, 약학적 중재를 실시한다. (예: 낙상 관련 의약품의 용량 또는 투여시간 조절 검토, 협의진료, 물리치료 시행 등)

④ 환경 및 시설을 관리한다. (예: 바닥 미끄럼, 조명, 환자주변 정리, 사이드레일 사용, 휠체어 고정 등)

(3) 중환자실

① 침대에서 계속 움직이며 불안정한 모습을 보이는 환자는 필요 시 침대 난간사이에 낙상방지판을 끼운다.

② 본인이 침대 높이를 조절하지 않도록 고정하는 것을 고려한다.

③ 필요 시 의사의 처방에 따라 신체보호대를 적용한다.

④ 필요 시 침대이탈 알람 등의 사용을 고려할 수 있다.

(4) 소아 환아

① 낙상 위험이 있는 소아는 혼자 두지 않고 반드시 보호자와 함께 있도록 한다.

② 침대위에 서서 옷을 갈아입거나 침대위에서 뛰지 않도록 한다.

③ 유모차 이용시에는 환아에게 안전바와 안전벨트를 착용시키도록 한다.

④ 환아가 복도에서 뛰어다니지 않도록 하고, 수액걸이(IV Pole)를 혼자 밀고 다니거나 그 위에 올라서서 타고 다니지 않도록 한다.

(5) 환자 이동/이송 시 낙상 예방 중재 활동

① 보행이 가능한 환자 이송 시 보행속도에 맞춰 이동한다.

② 환자를 침대 또는 이송침대로 옮길 때에는 바퀴를 고정하고 침상 난간은 올린 상태에서 이동한다.

③ 이송을 마친 후 침대나 휠체어, 유모차 바퀴는 고정하고 환자침대 높이는 최저로 낮춘다.

④ 이동/이송 시 IV Pole, 엘리베이터 턱, 보행기구 등에 발이 걸려 넘어지지 않도록 주의한다.

3. 외래환자 및 가정간호 환자의 낙상위험 스크리닝 및 관리

1) 낙상위험 스크리닝 대상: 모든 외래 및 가정간호 환자

2) 낙상평가 방법: '외래초기평가'의 낙상 스크리닝 항목(12개월 이내 낙상 경험, 보조기 사용, 당일 진정제 사용(예정) 유무)을 이용하여 낙상위험요인 평가 시행

3) 낙상 고위험군: 낙상 스크리닝 항목 3개 중 1가지 이상 해당되는 경우

4) 낙상 고위험군 환자의 낙상 예방 활동

(1) 외래 환자는 '낙상주의' 스티커를 이용하여 낙상 고위험 환자임을 의료진, 환자 및 보호자와 정보를 공유한다.

(2) 환자 및 보호자에게 '낙상예방' 안내문을 제공하고 주의사항에 대해 교육한다.

(3) 외래 진료 구역마다 특성에 맞는 낙상 예방활동을 수행한다. [부록1. 낙상예방 관리지침] 참고

4. 낙상 발생 가능 검사실 및 치료실 환자의 낙상 예방활동

1) 진정 하 검사 또는 시술 시행, 검진대로 옮기거나 눕는 과정에서 몸의 위치가 변경되는 경우, 낙상 위험이 높은 기구 사용 등 낙상 발생 가능성이 높은 경우, 부서 특성에 맞는

낙상 예방활동을 수행한다. [부록1. 낙상예방 관리지침] 참고

5. 응급진료센터 환자의 낙상 예방활동
   1) 응급진료센터 내원 시 모든 환자를 대상으로 낙상예방지침을 사용하여 환자 및 보호자에게 교육하고, '낙상주의' 게시물을 침대에 부착한다.
   2) 보호자가 바뀔 경우에는 낙상예방지침 내용을 인계하도록 교육한다.
   3) 낙상위험평가 결과에 따른 낙상예방활동을 수행한다. (입원환자와 동일)
   4) 구급차 이송침대에서 환자를 옮길 때는 이송침대와 침대가 같은 높이가 되도록 침대 높이를 조절하고, 침대와 구급차 이송침대의 바퀴를 반드시 고정한다.

6. 수술실의 낙상예방활동은 [부록1. 낙상예방 관리지침]을 따른다.

7. 낙상 발생 시 대처
   1) 입원/응급진료센터/수술실 입실 환자
      (1) 낙상 발생 즉시 환자 상태(의식상태, 활력징후, 통증 및 상해여부)를 확인한다.
      (2) 담당의사 또는 주치의(담당교수)에게 보고하고 환자 상태에 따라 필요한 검사, 처치 및 진료과 협진을 시행한다.
      (3) 낙상 발생 상황 및 관련 경과를 의무기록에 기록한다.
      (4) 환자안전보고체계에 따라 전산, 서면 또는 구두로 환자안전팀 환자안전파트에 보고한다. 적신호사건은 사건 발생 또는 사건 인지 24시간 이내에 보고한다.
      (5) 낙상 발생 사례 및 예방 방법 등을 직원과 공유하여 재발방지 교육을 실시한다.
   2) 외래/검사실/치료실 환자
      (1) 낙상 발생 즉시 환자 상태(의식상태, 활력징후, 통증 및 상해여부)를 확인한다.
      (2) 부서장 및 주치의(담당교수)에게 보고하고 환자 상태에 따라 필요한 검사 및 처치를 시행한다.
      (3) 입원환자가 검사실이나 치료실에서 낙상한 경우 부서장 및 주치의(담당교수)에게 보고하고 입원 병실에 관련 사항을 인수인계한다.
      (4) 환자안전보고체계에 따라 전산, 서면 또는 구두로 환자안전팀 환자안전파트에 보고한다. 적신호 사건은 사건 발생 또는 사건 인지 후 24시간 이내에 보고한다.
      (5) 낙상 발생 사례 및 예방 방법 등을 직원과 공유하여 재발하지 않도록 교육한다.

8. 분기별로 낙상 발생률과 의도하지 않은 낙상 예방활동의 결과를 모니터링하고, 결과를 병원운영위원회 및 세브란스병원장에게 보고하고 관련 직원과 공유한다.

제4조 (부록)
1. 낙상예방 관리지침

제5조 (참고)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)